

약제 요양급여의 적정성 평가결과

inebilizumab 100mg

(업리즈나주(이네빌리주맙), 미쓰비시다나베파마코리아(주))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1병(10mL) 중 inebilizumab 100mg

☐ 효능·효과

- 항아쿠아포린-4(Aquaporin-4, AQP4) 항체 양성인 성인 환자에서의 시신경척수염범주질환의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2024년 제7차 약제급여평가위원회: 2024년 7월 4일

- 약제 급여기준 소위원회 심의일: 2024년 4월 19일, 2024년 5월 17일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “항아쿠아포린-4 항체 양성 성인환자에서의 시신경척수염범주질환의 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제와 효과가 유사하나, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
- 다만, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■■ 원/병) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 100%, ■■■■■ 원/병) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.
- 또한, 신청품은 경제성평가 자료제출 생략가능 약제와 치료적 위치가 동등한 후속제품으로 대체약제의 위험분담제 계약 내용 등을 고려한 협상이 필요함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “항아쿠아포린-4(Aquaporin-4, AQP4) 항체 양성인 성인 환자에서의 시신경척수염범주질환의 치료”에 허가된 약제로 현재 satralizumab, eculizumab 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “항아쿠아포린-4 항체 양성 성인환자에서의 시신경척수염범주질환의 치료”에 허가된 약제로 CD19-표적 인간화 단클론항체임.
 - 신청품은 B세포에서 발현하는 CD19에 결합하여 항체 의존적인 세포-매개 B세포 고갈작용¹⁾을 함. CD20에 작용하는 약제에 비해 CD19를 발현하는 형질아세포(plasmablast) 및 형질세포(plasma cell)까지 소실시켜 보다 광범위한 B세포 계열의 소실을 유도할 수 있는 특징이 있음.
- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾에서는 시신경척수염범주질환(NMOSD)에 ‘연간 재발률 또는 재발까지의 시간’을 감소하는 효과를 증명하여 허가된 세 가지 단클론항체 치료⁵⁾ 중 하나로 수재되어 있고, 임상진료지침⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾에서 항 아쿠아포린-4 항체 양성 NMOSD에 신청품은 first choice로 권고됨.
- [N-MOmentum, 위약 대조 2/3상]¹⁰⁾ 시신경척수염범주질환 성인 환자¹¹⁾를 대상으로 신청품군과 위약군으로 3:1 무작위 배정¹²⁾하여 유효성 및 안전성을 평가한 다국가, 다기

관¹³⁾, 이중눈가림, 무작위배정, 위약대조, 임상 2/3상 연구 결과,

- (1차 유효성 평가변수) ‘심사위원회 정의에 따른 NMOSD attack까지의 기간’¹⁴⁾¹⁵⁾은 신청품군에서 위약군 대비 유의하게 증가하였음.
 - ✓ 전체 ITT군 분석: 신청품군 12%(21명/174명) vs. 위약군 39%(22명/56명)의 환자에서 attack이 발생함. (HR 0.272, 95%CI 0.150-0.496, $p < 0.0001$)
 - ✓ AQP4-IgG 양성 하위군¹⁶⁾: 신청품군 11%(18명/161명) vs. 위약군 42%(22명/52명)의 환자에서 attack이 발생함. (HR 0.227, 95%CI 0.121-0.423, $p < 0.0001$)
 - ✓ 신청품의 CD20 B세포에 대한 약력학적 효과(pharmacodynamic effect)는 4주 이내에 관찰되었고, 위약 대비 유의하게 CD20 B cell을 감소시켰음.
- (2차 유효성 평가변수) 네 가지 주요 2차 지표는 기저치 대비 EDSS 점수 악화¹⁷⁾¹⁸⁾, 기저치 대비 저대비 양안 시력 점수¹⁹⁾, 총 누적 활성 MRI 병변 수²⁰⁾, NMOSD 관련 입원 일수²¹⁾로,
 - ✓ EDSS 점수가 악화된 환자는 신청품군에서 위약군 대비 통계적으로 유의하게 적었음. (ITT: 신청품군 16% vs. 위약군 34%, OR 0.370 95%CI 0.185-0.739, $p < 0.0049$)
 - ✓ 저대비 양안 시력 점수는 양군 간 유의한 차이가 없었으며, 사후 민감도 분석 결과 신청품 투여군에서 시신경염(optic neuritis)를 경험한 환자가 더 적었음.
 - ✓ 누적 활성 MRI 병변 수²²⁾와 NMOSD 관련 입원 일수²³⁾는 신청품군에서 위약군 대비 더 적었음.
- (안전성 평가) 신청품군 72%(125명/174명), 위약군 73%(41명/56명)의 환자에서 이상반응이 발생함.
 - ✓ 주입 관련 이상반응을 포함한 대부분 이상반응은 두 군간 유사한 빈도로 발생하였으나, 요로감염, 관절통, 요통, 두통, 낙상, 감각 저하, 방광염, 안구 통증은 신청품 투여군에서 더 많은 빈도로 발생함.
 - ✓ 심각한 이상반응은 신청품군 8명(5%), 위약군 5명(9%)에서 발생하였고, randomised controlled period 동안 사망은 발생하지 않음²⁴⁾.
 - ✓ AQP4-IgG 혈청 양성 그룹의 안전성 평가변수는 ITT 그룹의 결과와 유사하였음.

- [N-MOmentum, 연장연구]²⁵⁾ 시신경척수염범주질환 성인 환자 대상 위약대조 2/3상 연구의 공개표지(open-label) 연장 연구²⁶⁾²⁷⁾ 최종 결과,

- (유효성 평가변수)²⁸⁾ ‘심사위원회가 정의한 재발(attack)까지의 기간’²⁹⁾과 ‘연간 재발률(annualised attack rate)’를 분석함.
 - ✓ 신청품을 투여 받은 전체 환자³⁰⁾³¹⁾ 225명 중 47명(21%)에서 63건의 재발(attack)이 발생함. 발생한 재발(attack)의 63%(40건/63건)는 15%(34명/225명)의 환자에서 투여 첫 해에 발생하였고, 신청품을 투여 받는 동안 재발이 있었던 환자의 77%(36명/47명)는 이후 4년까지 재발하지 않았음. 4년차 attack-free 추정치는

77%이었음.

- ✓ AQP-4-IgG seropositive 하위군 208명 중 44명(21%)에서 60건의 attack이 발생함. 전체 신청품 투여군의 결과와 유사하였음.
- ✓ 연간 재발률(adjusted annualised attack rate)의 최종 분석 결과는 전체 신청품 투여군에서 0.092(0.067-0.127), AQP-4-IgG seropositive 하위군에서 0.097(0.070-0.14)이었음. 연간 재발률은 두 그룹에서 모두 지속적으로 감소하였음.
- (안전성 평가) safety profile은 randomised controlled period에서의 신청품 투여군의 결과와 유사하였음.
 - ✓ 신청품 투여군³²⁾의 92%(208명/225명)에서 하나 이상의 치료관련 이상반응이 보고되었음.
 - ✓ 가장 흔한 이상반응은 요로감염(26%), 비인두염(21%), 관절통(17%)이었고 4년 동안 감염률(infection rates)은 증가하지 않았음.
 - ✓ open-label period 동안 사망 3건³³⁾이 발생함.
- [N-MOmentum, prior rituximab 투여군 분석]³⁴⁾ N-MOmentum 연구³⁵⁾에서 rituximab을 투여한 경험이 있는 환자 17명³⁶⁾³⁷⁾을 대상으로 사후 분석(post-hoc analysis)을 수행한 결과,
 - (유효성 평가) 연간 재발률(Annualized attack rate, AARs), 기저치 대비 EDSS 점수 변화, MRI 상의 활성 병변의 수, NMOSD 관련 입원 일수로,
 - ✓ 무작위 대조기간(RCP) 동안 ‘rituximab 투여 경험 신청품 투여군’의 8%(1명/13명), 전체 위약군³⁸⁾의 39%(22명/56명)가 재발함. (HR 0.16, 95%CI 0.02-1.20, p=0.07)
 - ✓ 신청품 첫 투여 후 연간 재발률은 이전 rituximab 투여 경험이 있는 환자군(0.08건/인·년)과 없는 환자군(0.10건/인·년)에서 유사하였음.
 - ✓ 2차 유효성 평가지표 분석 결과, 이전 rituximab 사용 여부와 관계없이 전반적으로 유사하였음.
 - (안전성 평가) 신청품군의 치료관련 이상반응(TEAE)은 이전 rituximab 투여 환자군에서 53%(9명/17명), 미투여 환자군에서 38%(79명/208명) 발생함.
 - ✓ 중증 또는 3등급 이상 감염은 rituximab 투여 경험 환자군에서 18%(3명/17명), 미투여 환자군에서 각각 10%(20명/208명), 11%(22명/208명)이었음.
 - ✓ 이전 rituximab 투여 경험이 있는 신청품 투여군 모두에서 open-label 기간 동안 CD20 양성 B세포 수가 감소하였음
 - ✓ 신청품 투여 후 낮은 IgG 혈장농도 (IgG levels < 500mg/dL)를 보인 환자의 비율이 rituximab 투여 경험 환자군에서 35%(6명/17명)으로, rituximab 투여 경험이 없는 환자군의 15%(30명/208명)보다 높았음.
- [네트워크 메타분석]³⁹⁾ 항 아쿠아포린 항체 양성 NMOSD에 허가 받은 세 약제

(eculizumab, inebilizumab(신청품), satralizumab)를 비교하기 위해 Bayesian network meta-analysis를 수행한 결과,

- 4개의 RCT 연구(N-MOMentum⁴⁰⁾, PREVENT⁴¹⁾, SAKuraSky/SAkurastar⁴²⁾)로 출간된 29편의 문헌을 선정하여 공통 outcome인 ‘재발까지 걸린 시간’을 분석함. Eculizumab이 나머지 두 약제(inebilizumab, satralizumab)보다 재발까지 걸린 시간을 지연하는 효과가 가장 큰 것으로 분석됨.
- ✓ eculizumab이 가장 좋은 치료 옵션일 확률은 단독요법에서 98.67%, IST⁴³⁾ 병용요법에서 84.47%, 통합 97.63%로 분석되었으며, 단독요법에서 신청품이 가장 좋은 옵션일 확률은 0.74%, satralizumab은 0.59%로 분석됨. 신청품(inebilizumab) 단독요법⁴⁴⁾과 eculizumab 단독요법을 비교한 결과, HR 0.11(0.02-0.68)로 eculizumab이 더 우월하였음.
- (한계점) 연간 재발률(ARR), 장애정도(disability), 삶의 질(HRQoL), 안전성 평가(safety outcome)⁴⁵⁾가 자료의 한계로 네트워크 분석에서 제외됨.
- 관련 학회⁴⁶⁾에서는 신청품은 CD20을 표적으로 하는 rituximab 대비 B세포를 광범위하고 효과적으로 제거하므로 NMOSD 치료에 적합한 치료제이며, rituximab을 투여하였음에도 효과가 없거나 부작용으로 치료할 수 없는 경우 급여의 적정성이 있다는 의견임.
- 또한 inebilizumab, satralizumab, eculizumab 세 약제 모두 다른 표적에 작용하는 항체 치료제로 어느 한 약제에서 불충분한 반응을 보이거나 부작용이 있는 경우 상호 대체가 필요함.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 허가사항, 급여기준, 임상진료지침 등을 고려하여 satralizumab으로 선정함.
- (소요비용) 신청품의 치료기간⁴⁷⁾ 당 소요비용은 [] 원⁴⁸⁾으로 대체약제 소요비용인 [] 원 대비 고가임.
- 대체약제 가중평균가로 환산된 신청품의 단위비용 및 약가협상생략 기준금액⁴⁹⁾은 [] 원/병임.

○ 재정 영향⁵⁰⁾

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량⁵¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁵²⁾ 1차년도 약 [] 원, 3차년도 약 [] 원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 [] 원, 3차년도에 약 [] 원 증가될 것으로 예상됨⁵³⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량⁵⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁵⁵⁾은 1차년도

에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되며, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 5개국(미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) ADCC(Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity)
- 2) Harrison’s Principles of Internal Medicine, 21e. Chapter 445. Neuromyelitis Optica> Treatment of Neuromyelitis Optica
- 3) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2024. Chapter 26–20: Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder
- 4) Ferri’s Clinical Advisor, 2024, 964–966.e1. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder
- 5) ① eculizumab; a complement inhibitor ② inebilizumab; a humanized anti-CD19 antibody ③ satralizumab; an interleukin-6 inhibitor
- 6) Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) – revised recommendations of the Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS). Part II: Attack therapy and long-term management. J Neurol. 2024 Jan;271(1):141–176.
- 7) International Delphi Consensus on the Management of AQP4-IgG+ NMOSD: Recommendations for Eculizumab, Inebilizumab, and Satralizumab. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2023;10:e200124.
- 8) Contentti et al. Latin American consensus recommendations for management and treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders in clinical practice. Multiple Sclerosis and Related Disorders 45 (2020) 102428.
- 9) 시신경척수염 범주질환 환자를 위한 안내 책자. 한국다발성경화증협회(대한신경면역학회). 2023.
- 10) Cree BAC et. al. Inebilizumab for the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder (N-MOMentum): a double-blind, randomised placebo-controlled phase 2/3 trial Lancet 2019;394:1352 –63.
- 11) 등록기준
 - ① NMOSD로 진단 받은 만 18세 이상 성인
 - ② EDSS(Expanded Disability Status Scale) 8.0 이하 (무작위 배정 시 7.5 이하, 연구자가 참가 가능하다고 판단한 경우 8.0도 선정 가능)
 - ③ AQP4-IgG 양성 또는 음성 환자 (단, 음성의 경우 Wingerchuk 등(2006)의 NMOSD 임상기준 충족)
 - ④ 구제치료(rescue therapy, 정맥 스테로이드, 정맥 면역글로블린, 혈장교환 혹은 이상의 혼합 요법)를 요하는 재발(attack)이 최근 1년간 적어도 1회 내지는 2년간 적어도 2회 발생 이력
- 12) 투여 방법

구분	투여 방법
시험군 (n=174)	Day 1, Day 15에 각각 inebilizumab 300mg, IV (RCP* 동안 총 투여량은 600mg 이고 15일차 이후 추가 투여는 안 함.) * Randomised controlled period: 최대 197일 또는 adjudicated attack 발생까지
위약군 (n=56)	Day 1, Day 15에 각각 placebo 300mg, IV
- 13) 25개 국가, 99개 기관
- 14) 심사위원회 정의에 따른 NMOSD attack까지의 기간으로 최대 197일까지 확인: time (in days) from day 1 to the onset of an NMOSD attack (as determined by the adjudication committee), on or before day 197.
- 15) attack의 정의: 시력감소, 보행 장애, 뇌병변 관련 증상 등 신경학적 평가에 의해 프로토콜에서 정의된 기준을 하나 이상 충족하는 NMOSD 관련 새로운 증상 발생 또는 기존 증상의 악화
- 16) AQP-IgG-seropositive: 92.6% (213명/230명)
- 17) EDSS(Expanded Disability Status Scale): 다발성경화증(MS) 환자에서 장애 정도를 정량적으로 평가하는 척도로, 0점(normal neurological exam)에서 10점(MS로 인한 death)으로 평가함. (Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology. 1983 Nov;33(11):1444–52.)

Score (일부 발책)	Description
6.5	Constant bilateral assistance (canes, crutches, braces) required to walk about 20 meters without resting; (Usual FS equivalents are combinations with more than two FS grade 3+).
7.0	Unable to walk beyond approximately 5 meters even with aid, essentially restricted to wheelchair; wheels self in standard wheelchair and transfers alone; up and about in wheelchair some 12 hours a day; (Usual FS equivalents are combinations with more than one FS grade 4+; very rarely pyramidal grade 5 alone).
7.5	Unable to take more than a few steps; restricted to wheelchair; may need aid in transfer; wheels self but cannot carry on in standard wheelchair a full day; May require motorized wheelchair; (Usual FS equivalents are combinations with more than one FS grade 4+).
8.0	Essentially restricted to bed or chair or perambulated in wheelchair, but may be out of bed itself much of the day; retains many self-care functions; generally has effective use of arms; (Usual FS equivalents are combinations, generally grade 4+ in several systems).

- 18) worsening of EDSS score from baseline (increase of ≥ 2 from baseline of 0, increase of ≥ 1 from baseline of 1 - 5, or increase of ≥ 0.5 from baseline of ≥ 5.5)
- 19) change from baseline in low-contrast visual acuity binocular score (by low-contrast Landolt C Broken Ring Chart)
- 20) cumulative total number of active MRI lesions (new gadolinium-enhancing lesions, or new or enlarging T2 lesions, measured across the optic nerve, brain, brainstem, and spinal cord)
- 21) number of NMOSD-related inpatient hospitalisations, longer than an overnight stay
- 22) Cumulative number of active MRI lesions from baseline (ITT, 평균): 신청품군 1.6 vs. 위약군 2.3
- 23) Cumulative number of NMOSD-related inpatient hospitalisations from baseline (ITT, 평균): 신청품군 1.0일 vs. 위약군 1.4일
- 24) open-label period에 사망 2건이 보고됨. (위약군 serious adverse event of pneumonia, 신청품군 cardiopulmonary complications)
- 25) Cree BAC, et al. Safety and efficacy of inebilizumab for the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder: end-of-study results from the open-label period of the N-MOMentum trial. Lancet Neurol. 2024;23(6):588-602.
- 26) 2015.1.6.~2018.9.24. 467명의 환자가 선정됨. 이중 231명이 무작위 배정되어, 230명의 환자가 신청품(174명) 또는 위약(56명)을 투여 받았음. 2015.5.19.~2018.11.8. 신청품군의 95%(165명/174명), 위약군의 91%(51명/56명)이 open-label period에 참여하여 inebilizumab을 투여받음.
- 27) 24개국, 81기관이 모집됨. Data cutoff: 2020.12.18.
- 28) end-of-study analysis endpoint: ① time to adjudicated attack ② annualised attack rate
- 29) 심사위원회(adjudication committee) 정의에 따른 재발(attack)까지의 기간
- 30) Any inebilizumab population: randomised controlled period, open-label period을 포함하여 신청품을 투여 받은 전체 환자
- 31) 신청품 투여군(any inebilizumab population)에서 평균 투여기간은 1,161일(SD 496)이었음. 35.9%의 환자가 4년을 초과하여 투여받음. (90.6% (n=204) had >1 year, 84.8% (n=191) had >2 years, 55.4% (n=125) had >3 years, and 35.9% (n=81) had >4 years of exposure to inebilizumab)
- 32) Any inebilizumab population
- 33) 원인 불명의 CNS event 1건, 폐렴 1건, NMOSD 재발로 인한 호흡부전 및 COVID-19으로 인한 바이러스성 폐렴 1건
- 34) Flanagan EP, et al. Inebilizumab for treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder in patients with prior rituximab use from the N-MOMentum Study. Mult Scler Relat Disord. 2022;57:103352.

- 35) RCP(randomized controlled period), OLE(open-label extension) 기간 동안 rituximab 이전 투여 환자군에 대해 재발(Adjudicated attacks), 2차 유효성 지표, 치료관련 이상반응을 평가함.
- 36) rituximab과 inebilizumab이 모두 B-cell에 작용하는 유사한 기전을 갖고 있기 때문에 가장 최근의 rituximab 투여가 6개월 이상 지났거나 B-cell count 결과가 정상 하한선 이상으로 회복된 환자를 대상으로 함.
- 37) 17명의 환자가 rituximab을 투여한 경험이 있었고, 이중 13명이 inebilizumab 투여군, 4명이 위약군으로 배정되었음.
- 38) rituximab 이전 투여 경험과 무관한 전체 위약군
- 39) 학회가 제출한 단클론항체 치료를 비교한 네트워크 메타분석 문헌을 추가 분석함. Dean M. Wingerchuk, et al. Network Meta-analysis of Food and Drug Administration-approved Treatment Options for Adults with Aquaporin-4 Immunoglobulin G-positive Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. Neurol Ther (2022) 11:123 - 135
- 40) N-MOMentumin trial: inebilizumab(신청품)
- 41) PREVENT trial: eculizumab
- 42) SAKuraSky/SAkurastar trial: satralizumab
- 43) IST; Immunosuppressive therapy
- 44) 신청품의 경우 임상에서 IST 병용을 허용하지 않았으므로 단독요법에 대한 결과만 있어 단독요법을 비교한 결과만 분석되었음.
- 45) 대체약제 검토 시 조회된 학회의견에서 eculizumab 관련 안전성 언급이 있었음. eculizumab의 경우 기회감염의 위험성을 증가할 수 있어 수막구균 패혈증 증례가 보고된 바 있고, FDA 허가에 black box warning으로 치명적인 수막구균 감염 가능성이 포함되어 있으며, 국내 허가에도 eculizumab 치료 전에 수막구균 백신을 접종 받도록 하고 있음. (대한신경면역학회, 대신면 제 2023-005호, 2023.5.15.)
- 46) 대한신경면역학회(), 대한안과학회(), 대한신경과학회()
- 47) 치료기간은 신청품 임상연구(N-MOMentumin)에서의 평균 투약기간()일을 적용함.
- 48) 주입 반응 관련 전처치 비용()원/1회 포함 금액임.
- 49) 신청품은 생물의약품으로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항 제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라, 약가협상생략기준금액은 대체약제의 가중평균금액(신청약제의 단위 비용으로 환산된 금액)의 100% 금액임.
- 50) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 51) 제약사 제출 예상 사용량

구분	1차년도	2차년도	3차년도
연간 예상 사용량	) 병	) 병	) 병

- 52) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
- 53) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량
- 54) 제약사 제출 예상 사용량

구분	1차년도	2차년도	3차년도
연간 예상 사용량	) 병	) 병	) 병

- 55) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가